

RASolute 302

Daraxonrasib 治療曾接受治療之轉移性胰臟癌

Oral RAS(ON) Inhibitor vs Chemotherapy in mPDAC

讀書會共筆整理 | 謝慕揚 MD, PhD, FESC · 2026-06-04

原文：[N Engl J Med 2026 \(DOI 10.1056/NEJMoa2605555\)](https://doi.org/10.1056/NEJMoa2605555)

一句話總結

- 曾接受治療之 **mPDAC**，口服 **RAS(ON)** 多選擇性抑制劑 **daraxonrasib** vs 化療
- **RAS G12 族群：中位 OS 13.2 vs 6.6 個月 (HR 0.40 , P<0.001)**
- 中位 **PFS 7.3 vs 3.5 個月**

RAS 標靶在最致命癌症之一取得明確存活益處——**死亡風險降低約 60%。**

背景：胰臟癌與 RAS

- mPDAC 中位 OS **< 1 年**；二線無標準療法，化療反應差
- **>90% PDAC 帶 RAS 突變**，其中 **>80% 為 KRAS codon 12** (G12D/G12V 為主)
- 突變 → 持續活化 **RAS(ON) (GTP 結合態)** → 異常訊號
- RAS 過去被視為 **「不可成藥」**

目標：直接把胰臟癌的根本驅動因子 RAS 「關掉」。

Daraxonrasib：機轉

- 口服、強效 **RAS(ON)** 多選擇性、三元複合體抑制劑
- 結合細胞內 **cyclophilin A** → 結合活化態 RAS(ON) → 抑制下游
- **多選擇性**：作用於多種突變型 + 野生型 RAS

與 G12C 專一抑制劑 (sotorasib/adagrasib) 不同——胰臟癌以 **G12D/G12V** 為主，需要多選擇性。

研究設計 (PICO)

元素	內容
P	曾接受治療之 mPDAC
I	Daraxonrasib 300 mg PO QD
C	研究者選擇化療 (gem+nab-pac / mFOLFIRINOX / FOLFOX / nal-IRI+5FU/LV)
O	RAS G12 族群之 OS 與 PFS (雙主要終點)

- 國際、開放標籤、第三期、1:1 隨機

主要結果

終點 (RAS G12)	Daraxonrasib	化療	效果
中位 OS	13.2 月 (10.0–NR)	6.6 月 (5.4–8.2)	HR 0.40, P<0.001
中位 PFS	7.3 月	3.5 月	顯著改善

- HR 0.40 在 **RAS G12 與整體族群皆相同** → 益處一致

OS 接近**倍增**，在二線 mPDAC 屬重大進展。

安全性與限制

- 口服標靶藥，毒性型態與化療不同；整體可耐受（詳見原文）
- **限制：**
 - 開放標籤、對照為混合化療（異質性高）
 - 隨訪進行中，長期存活與**抗藥性**待觀察
 - 排除 CNS 轉移與先前 RAS 標靶者
- Cardio-oncology：新藥類別之心血管長期安全性值得追蹤（非本試驗結論）

Take-home

1. RAS 曾「不可成藥」；daraxonrasib 為口服 RAS(ON) 多選擇性抑制劑，打到 G12D/G12V。
2. RASolute 302：mPDAC 二線 **OS 13.2 vs 6.6 月 (HR 0.40)**、PFS 7.3 vs 3.5 月。
3. 多選擇性 > G12C 專一性，更適合以 G12 為主的胰臟癌。

參考文獻

1. O'Reilly EM, Wainberg ZA, Hendifar AE, et al. Daraxonrasib or Chemotherapy in Previously Treated Metastatic Pancreatic Cancer (**RASolute 302**). *N Engl J Med*. 2026 May 31. DOI [10.1056/NEJMoa2605555](https://doi.org/10.1056/NEJMoa2605555) · [PubMed 42223072](#)
2. Hong DS, et al. KRAS^{G12C} Inhibition with Sotorasib. *N Engl J Med*. 2020;383:1207-1217. [PubMed 32955176](#)

謝謝聆聽

Q & A

讀書會共筆整理 | 謝慕揚 MD, PhD, FESC

本投影片由 *Claude Code* 協助整理，內容已核對原文